Casa di Cura Villa Liriope
Accreditata con il Servizio Sanitario Regionale
Servizio di Neuroradiologia Diagnostica
Direttore Sanitario: Dott.ssa Ornella Ciampi

Via Monte Senario Nuovo 48
00141 Roma
Tel. 06 87134520
neuroradiologia@villaliriope.example.it

REFERTO DI RISONANZA MAGNETICA

RM encefalo e midollo cervicale senza e con mezzo di contrasto

DATI DEL PAZIENTE

Cognome e nome:	**Pellegrino Chiara**	Data di nascita:	**19/01/1987**
Codice fiscale:	**PLLCHR87A59E472C**	Peso dichiarato:	**62 kg**
Medico inviante:	**Dott. Fabrizio Orlandi**	Struttura inviante:	**Centro Sclerosi Multipla, Ospedale San Ruffillo**

Esame n.:	RM/25/30917	Data esame:	09/10/2025
Impegnativa NRE:	120A03718842661	Codice esenzione:	046

RM/25/30917

NOTIZIE CLINICHE

Pz. di 38 aa. affetta da sclerosi multipla recidivante-remittente, diagnosticata nel maggio 2019 secondo i criteri di McDonald, in trattamento con ocrelizumab 600 mg e.v. ogni sei mesi (ultima infusione il 2 aprile 2025). Riferisce parestesie all'arto superiore sinistro da circa tre settimane. Controllo RM annuale richiesto dal neurologo curante, Dott. Orlandi.
La sig.ra Pellegrino è accompagnata dal marito, sig. Andrea Cesaroni, che ha assistito alla compilazione del questionario di sicurezza.

Questionario di sicurezza RM (compilato e firmato dalla paziente)

- ☐ Pacemaker o defibrillatore
- ☐ Clip vascolari o stent
- ☐ Protesi o schegge metalliche
- ☐ Claustrofobia
- ☐ Gravidanza in atto
- ☐ Pregresse reazioni a mdc

TECNICA

Apparecchiatura a 3 Tesla. Sequenze 3D FLAIR, DIR, T2 TSE assiali, DWI e SWI; sequenza 3D T1 MPRAGE prima e dopo somministrazione endovenosa di gadobutrolo 1,0 mmol/mL alla dose di 0,1 mmol/kg. Studio del midollo cervicale con sequenze sagittali T2 e STIR e assiali T2* sui livelli patologici. Somministrazione del mezzo di contrasto a cura dell'inf. Daniela Sbardella; nessuna reazione avversa.

CONFRONTO

Confronto con gli esami RM del 14/03/2024 e del 03.10.24, eseguiti presso la nostra struttura con analoga tecnica.

REPERTI

Nella sostanza bianca sovratentoriale si confermano multiple lesioni iperintense in T2 e FLAIR a distribuzione periventricolare, iuxtacorticale e infratentoriale, alcune con morfologia ovoidale perpendicolare all'asse dei ventricoli laterali (dita di Dawson).
Rispetto al precedente controllo si riconosce una nuova lesione iuxtacorticale frontale destra di 5,5 mm, che presenta impregnazione contrastografica nodulare dopo gadolinio, indicativa di attività infiammatoria in atto. Le restanti lesioni sono invariate per numero e dimensioni e non mostrano enhancement.
Al midollo cervicale lesione iperintensa in T2 a livello C3-C4, eccentrica posterolaterale sinistra, di nuova comparsa rispetto all'esame del 03.10.24 e coerente con la sintomatologia riferita; non captante.

Sistema ventricolare in asse, di normali dimensioni. Non segni di atrofia cerebrale di rilievo per l'età. Non lesioni con caratteristiche suggestive di leucoencefalopatia multifocale progressiva.

Carico lesionale per distretto (sequenze FLAIR e T1 post-contrasto)

Distretto	Lesioni T2 totali	Nuove o ingrandite	Captanti gadolinio
Periventricolare	23	nessuna	nessuna
Iuxtacorticale / corticale	7	una, frontale dx	una, frontale dx
Infratentoriale	4	nessuna	nessuna
Midollo cervicale	2 (C3-C4, C6)	una, C3-C4	nessuna

CONCLUSIONI

Quadro RM di sclerosi multipla con attività radiologica di malattia: una nuova lesione iuxtacorticale frontale destra captante il mezzo di contrasto e una nuova lesione midollare a livello C3-C4, non captante.
Si segnala al neurologo curante per le valutazioni terapeutiche del caso.

Il Medico Neuroradiologo
Dott. Gianmarco Tedeschi
Esame in doppia lettura con la Dott.ssa Paola Ventura

CASA DI CURA VILLA LIRIOPE
Neuroradiologia
Dott. G. Tedeschi

Roma, 10 ottobre 2025

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.